Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro

Comarca de Belford Roxo

1ª Vara Cível da Comarca de Belford Roxo

Avenida Joaquim Costa Lima, S/N, São Bernardo, BELFORD ROXO - RJ - CEP: 26165-390

SENTENÇA

Processo: 0804477-33.2025.8.19.0008

Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

AUTOR: JULIANA FARIA GOUVEIA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-DPGE

RÉU: ESTADO DO RIO DE JANEIRO, MUNICIPIO DE BELFORD ROXO

Trata-se de "ação ordinária" ajuizada por JULIANA FARIA GOUVEIA em face do MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO e do ESTADO DO RIO DE JANEIRO, por meio da qual a parte autora objetiva a proteção de seu direito à saúde, a partir do fornecimento de fármaco denominado "VENLAFAXINA – 150 MG", "ARIPIPRAZOL – 10MG" e "MIRTAZAPINA – 45MG", segundo os critérios de posologia indicados em relatório médico (ID 179656955).

A decisão de ID 179774687 deferiu a gratuidade de justiça à parte autora, assim como concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, determinando aos corréus que fornecessem os fármacos descritos na inicial.

Contestação do Estado em ID 186378931, informando que os fármacos pleiteados na inicial, embora registrados na ANVISA, não foram inseridos nos protocolos clínicos do SUS.

Contestação da Municipalidade em ID 189918562.

Réplica no ID 233871073.

Esse é, em síntese, o **relatório**. Passo a decidir, observado o dever de **fundamentação constitucionalmente adequada** insculpido no art. 93, inciso IX, da CF/88 cc. art. 489 do CPC/2015.

Partes devidamente representadas, inexistindo nulidades. Estão presentes os pressupostos de existência e os requisitos para prosseguimento válido do processo.

Verifico, ainda, as condições indispensáveis ao regular exercício do direito de ação.

As questões preliminares invocadas pela Municipalidade não se sustentam.

A petição inicial é apta, sendo certo que o valor atribuído à causa respeitou às disposições do art. 292 do CPC/2015, ainda mais se considerado que o direito controvertido apresenta conteúdo econômico inestimável.

Ademais, o Município é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Na realidade, a obrigação de prestar os serviços essenciais à saúde do cidadão é de cariz solidário, podendo o titular do direito direcionar a sua pretensão contra quaisquer das três esferas da federação, ressalvadas as situações excepcionais em que existe responsabilidade administrativa exclusiva da União (vide Temas nº 793 e 1.234 da repercussão geral do E. STF).

Para a hipótese em testilha, o fármaco pleiteado pela parte autora é registrado na ANVISA e, embora não tenha sido incorporado aos protocolos clínicos do SUS, não se insere dentre aqueles considerados de “alto custo/alta complexidade”, o que afasta a legitimidade exclusiva da União.

Desse modo, REJEITO as preliminares invocadas pela Municipalidade.

Cabível o julgamento do feito no estado em que se encontra, uma vez que os elementos de informação coligidos aos autos se revelam suficientes para a adequada elucidação da controvérsia (arts. 370 e 371, do CPC/2015).

O cerne do litígio em exame consiste em descortinar se há, ou não, o direito da parte autora de receber o tratamento médico considerado indispensável para proteção de sua saúde (e, por conseguinte, de sua vida), observada a sua hipossuficiência econômica para custeá-lo por conta própria.

O exercício do direito à saúde exige o correspondente dever solidário das Administrações Federal, Estadual e Municipal. A propósito, este é o teor do Enunciado nº 65 da Súmula desta Corte de Justiça: *"Deriva-se dos mandamentos dos artigos 6º e 196 da Constituição Federal de 1988 e da Lei nº 8080/90, a responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios, garantindo o fundamental direito à saúde e consequente antecipação da respectiva tutela.*".

Como já lançado linhas acima, restou comprovado por meio do laudo médico (ID 179656958) a necessidade do paciente de utilizar as **medicações** imprescindíveis para a preservação de sua saúde.

Assim é que as disposições contidas nos artigos 196 e 198 da CF/88 devem ser prontamente observadas pela parte ré.

> *"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.*
>
> *(...)*
>
> *Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:"*

Registre-se que não existe ofensa ao princípio da reserva do possível, tampouco ausência de previsão orçamentária, tendo em vista a preponderância dos princípios da dignidade humana, do mínimo existencial e da priorização da saúde, na forma do art. 198, § 2º, da CF/88.

Com efeito, a saúde integra a seguridade social e é regida pelos princípios da universalidade da cobertura e do atendimento, constituindo direito fundamental que não pode ser postergado em face de contingências orçamentárias ou administrativas.

Segue daí que referido direito (à saúde), por se apoiar diretamente na CF/88, tem sua proteção incondicional e não traduz qualquer tipo de vulneração à independência dos poderes ou aos primados da isonomia, da igualdade e da impessoalidade.

Sob essa perspectiva constitucional, o direito à saúde pode ser visualizado sob os ângulos coletivo e individual, na medida em que, conquanto seja direito público subjetivo, deve ser assegurado por meio de políticas sociais e econômicas de cunho universal.

A propósito, disciplina o Ministro GILMAR FERREIRA MENDES: *"Não há direito absoluto a todo e qualquer procedimento necessário para proteção, promoção e recuperação da saúde, independentemente da existência de uma política pública que o concretize. Há um direito público subjetivo a políticas públicas que promovam, protejam e recuperem a saúde."* (Curso de Direito Constitucional, 7ª ed. Saraiva, p. 697).

Dentro dessa moldura constitucional, se existe prescrição médica para o **fornecimento de tratamento médico imprescindível à vida do paciente**, exsurge o direito público subjetivo oponível ao Estado (lato sensu), independentemente de questões orçamentárias ou da política estatal para o setor, sob pena de restar sonegado, em sua essência, o direito à saúde e o próprio direito à vida.

Vale dizer, estando em risco a própria vida, o aspecto individual do direito à saúde sobrepõe-se ao aspecto coletivo, exclusivamente orçamentário, já que em situações dessa natureza não há como estabelecer ponderações que possam resguardar minimamente o direito individual à vida.

Cumpre, enfim, enfrentar a questão atinente ao adequado direcionamento da determinação judicial (a quem incumbe o cumprimento).

Importante reforçar que entre as entidades de direito público interno, subsiste a responsabilidade solidária no que tange ao funcionamento do Sistema Único de Saúde SUS (art. 198, II, da CF), ainda que se deva respeitar os critérios administrativos de distribuição das competências.

Aliás, no julgamento do Tema nº 1.234, submetido ao rito da repercussão geral, o E. STF delineou que:

> **I. COMPETÊNCIA**
>
> 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG –

situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.
(...)

II. DEFINIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS
2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico.
2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema.

(...)

7.3) Até que sobrevenha a implementação da plataforma, os juízes devem intimar a Administração Pública para justificar a negativa de fornecimento na seara administrativa, nos moldes do presente acordo e dos fluxos aprovados na Comissão Especial, de modo a viabilizar a análise da legalidade do ato de indeferimento.

Já em sede de embargos de declaração, a Suprema Corte esclareceu que: "*Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC". 3.* ***Embargos de declaração da União parcialmente acolhidos, quanto à modulação de efeitos, em relação à competência, também no que tange aos medicamentos incorporados***. ***Consequentemente, os efeitos do tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (19.9.2024)***.".

Por estas razões, embora reconhecido que os fármacos pleiteados pela paciente não tenham sido incorporados aos protocolos clínicos do SUS, não cuidou a Administração Pública de ilidir os elementos de informação colacionados pela parte autora e que indicam a ineficácia dos tratamentos convencionais já realizados.

Ademais, não cuidaram os corréus de apresentar qualquer informação no sentido do porquê de os fármacos não terem sido incorporados aos protocolos clínicos do SUS ou da eficácia de tratamentos alternativos.

Assim, cabe aos Estados e aos Municípios o respectivo custeio, sem prejuízo de contrapartidas entre os próprios entes federados.

Pondere-se, por último, que, conquanto a data inserta na receita médica não represente empecilho à procedência da pretensão inicial, deverá o paciente, por uma questão de coerência e segurança jurídica, renová-la junto ao médico responsável, a cada novo requerimento de dispensação, para fins de demonstração da necessidade e eficácia da continuidade do tratamento (Enunciado nº 02, da I Jornada de Direito da Saúde promovida pelo CNJ).

Em caso de inércia do beneficiário, sem a demonstração da necessidade contínua do tratamento por meio do documento médico idôneo especificado supra, a eficácia da medida se esvairá uma vez presumível a superação da crise ou a sua convalescença. Ainda, ressalte-se que deverá o paciente, no caso de não utilização dos medicamentos por qualquer causa, proceder à sua imediata devolução junto ao órgão dispensador, inclusive sob pena de responsabilidade.

Diante do acima exposto, **JULGO PROCEDENTE o pedido,** no sentido de condenar a Municipalidade e o Estado, solidariamente, ao fornecimento e custeio dos fármacos descritos em ID 179656958, segundo os critérios de posologia indicados em relatório médico e enquanto perdurar a necessidade do paciente, a ser comprovada a cada novo pedido de dispensação.

EXTINGO o processo, com resolução do mérito, **na forma do art. 487, inciso I, do CPC/2015**.

Em vista da sucumbência da parte ré, condeno-a a ressarcir as despesas e custas do processo eventualmente adiantadas pela parte autora, à razão de 50% para cada, além do pagamento dos honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública do Estado, aqui arbitrados em R$ 1.500,00 (art. 85, §§2º, 3º e 8º, do CPC/2015), também à razão de 50% para cada sucumbente (vide Tema nº 1.002 da repercussão geral do STF). Observe-se eventual isenção de custas por parte da Administração Pública.

Dispensada a **remessa necessária**, em vista do valor do proveito econômico obtido na demanda, inferior aos quantitativos estabelecidos no art. 496 do CPC/2015.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Por último, atento ao requerimento formulado em ID 252568359, **INTIMEM-SE** os corréus para pagamento ou nota de empenho, com prova de depósito direto ao fornecedor indicado, **em 05 (cinco) dias**.

Transcorrido o prazo sem comprovação, será realizado o sequestro de verbas nas contas do(s) ente(s) e realizada a transferência para a conta bancária informada pelo fornecedor do medicamento, que será intimado para fins de requisição administrativa.

Com a transferência, intime-se o fornecedor para que, em 48 (quarenta e oito) horas entregue o medicamento diretamente ao ente federativo que suportou o sequestro de valores, sob pena da imposição de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao prazo de 30 (trinta) dias, cumprindo, por OJA de plantão e fazendo constar do mandado a advertência de que, nos termos do Tema 1234, eventuais discussões sobre o preço do medicamento não podem servir de empecilho para o fornecimento do medicamento ao jurisdicionado, não sendo possível entrega de valores superiores ao PMVG. Sem prejuízo do determinado no item “iv”, intime-se o ente federativo que suportou o sequestro de valores para que, tendo recebido o medicamento, entregue o medicamento ao requerente, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena da imposição de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao prazo de 30 (trinta) dias. Cumpra-se por OJA de plantão.

Oportunamente, ao arquivo, com as cautelas de praxe.

Belford Roxo, *data da assinatura eletrônica.*

RAFAEL SANTANA GARCIA
Juiz Titular

Assinado eletronicamente por: RAFAEL SANTANA GARCIA
23/01/2026 18:15:34
https://tjrj.pje.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento:

26012318153411800000245398924

IMPRIMIR GERAR PDF